

CURSO MODULAR — PSIQUIATRIA FORENSE

Pareceres Forenses por Tipo de Demanda

Curso robusto e operacional para produção de pareceres penais, cíveis, administrativos, trabalhistas, dano psíquico, análise crítica de laudos e quesitos.

Preparado para: Dr. Luís Henrique B. Gomes — Psiquiatra.

Base temática: Psiquiatria Forense de Taborda + aplicação prática pericial.

Finalidade: embasar pareceres robustos, otimizados e juridicamente úteis.

Curso Modular — Pareceres em Psiquiatria Forense

Base temática: Psiquiatria Forense de Taborda, 3ª edição, Artmed, 2016, articulada com prática médico-pericial e necessidades de elaboração de pareceres robustos.

Material autoral, operacional e aplicado. O objetivo não é resumir capítulos, mas construir um curso orientado à produção de pareceres psiquiátrico-forenses tecnicamente fortes.

Objetivo

Capacitar o psiquiatra a produzir pareceres robustos em diferentes contextos forenses, com raciocínio clínico, psicopatológico, funcional e médico-legal rastreável.

Estrutura

O curso é organizado em 8 módulos de parecer:

1. Parecer penal.
2. Parecer cível.
3. Parecer previdenciário/administrativo.
4. Parecer trabalhista/ocupacional.
5. Parecer de dano psíquico e nexo causal.
6. Análise crítica de laudo judicial.
7. Simulação, dissimulação e consistência.
8. Quesitos, conclusão e linguagem pericial.

Cada módulo contém:

- quando usar;
- pergunta médico-legal central;
- matriz de raciocínio;
- estrutura recomendada;
- conteúdo denso essencial;

- frases-modelo;
 - quesitos frecuentes;
 - checklist final.
-

Módulo 1 — Parecer Penal

1.1 Quando usar

Use este módulo para casos criminais envolvendo:

- imputabilidade penal;
- inimputabilidade;
- semi-imputabilidade;
- superveniência de doença mental;
- uso de substâncias e crime;
- psicose e conduta delituosa;
- transtorno bipolar e delito;
- deficiência intelectual e responsabilidade penal;
- medida de segurança;
- risco de violência;
- avaliação psiquiátrica em contexto prisional.

1.2 Pergunta médico-legal central

Ao tempo do fato, o examinado possuía capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e de determinar-se conforme esse entendimento?

Essa pergunta exige análise de dois eixos:

1. **Entendimento** — capacidade cognitiva de compreender a realidade, o ato, sua ilicitude e consequências.
2. **Autodeterminação** — capacidade volitiva de agir de acordo com esse entendimento.

1.3 Matriz de raciocínio penal

Eixo	O que avaliar	Fontes úteis	Impacto na conclusão
Diagnóstico	Psicose, mania, deficiência intelectual, substâncias, personalidade	Prontuário, entrevista, laudos, receitas	Diagnóstico é ponto de partida, não conclusão
Momento do fato	Sintomas ativos no período do delito	BO, depoimentos, prontuário contemporâneo	Sem reconstrução temporal, conclusão enfraquece
Entendimento	Juízo de realidade e ilicitude	Relato, comportamento, planejamento	Pode estar preservado, reduzido ou abolido
Autodeterminação	Capacidade de resistir, escolher, inibir	História do ato, impulsividade, psicose	Essencial para semi/inimputabilidade
Nexo	Relação sintoma-conduta	Conteúdo delirante, motivação, contexto	Sem nexos, diagnóstico pode ser irrelevante
Consistência	Simulação, dissimulação, contradições	Documentos e exame	Afeta grau de certeza

1.4 Estrutura recomendada do parecer penal

1. Objeto do parecer.
2. Síntese do fato imputado.
3. Documentos analisados.
4. Histórico psiquiátrico e criminal relevante.
5. Reconstrução do estado mental ao tempo do fato.
6. Exame psiquiátrico atual.
7. Diagnóstico e diagnósticos diferenciais.
8. Análise do entendimento.
9. Análise da autodeterminação.
10. Nexos entre transtorno e conduta.
11. Análise de substâncias, se aplicável.
12. Simulação/dissimulação/consistência.
13. Discussão médico-legal.
14. Conclusão.
15. Resposta aos quesitos.

16. Limitações.

1.5 Conteúdo denso essencial

Psicose e delito

A psicose tem relevância penal quando há sintomas ativos com repercussão direta sobre a conduta.

Elementos fortes:

- delírio persecutório ligado à vítima;
- alucinação imperativa relacionada ao ato;
- desorganização grave;
- perda de crítica;
- internação ou atendimento próximo ao fato;
- relatos convergentes de familiares/testemunhas;
- abandono recente de tratamento com descompensação.

Elementos que exigem cautela:

- crime planejado;
- ocultação sofisticada;
- motivação instrumental clara;
- ausência de sintomas contemporâneos;
- relato psicótico apenas após responsabilização.

Mania e delito

A mania pode reduzir autodeterminação em certos casos, especialmente quando há:

- grandiosidade;
- aceleração;
- redução de sono;
- desinibição;
- irritabilidade grave;
- impulsividade extrema;
- psicose afetiva;
- prejuízo crítico documentado.

Substâncias

Distinguir:

- intoxicação voluntária comum;
- intoxicação patológica;
- delirium por substância;
- psicose induzida;
- abstinência grave;
- dependência com prejuízo funcional crônico.

Personalidade e psicopatia

Transtorno de personalidade ou psicopatia geralmente não exclui imputabilidade por si só. Pode ser relevante para risco, prognóstico e padrão comportamental, mas não deve ser usado como rótulo moral.

1.6 Frases-modelo

Imputabilidade preservada

Embora haja diagnóstico de [DIAGNÓSTICO], os elementos clínicos e documentais disponíveis não demonstram que, ao tempo do fato, tal condição tenha abolido ou reduzido de forma juridicamente relevante sua capacidade de entendimento ou autodeterminação.

Semi-imputabilidade

Os dados disponíveis indicam comprometimento parcial da capacidade de [ENTENDIMENTO/AUTODETERMINAÇÃO] ao tempo do fato, relacionado a [SINTOMAS], sem elementos suficientes para afirmar abolição completa da capacidade penal.

Inimputabilidade

O conjunto dos elementos analisados sustenta que, ao tempo do fato, o examinado apresentava [ESTADO PSICOPATOLÓGICO], com abolição da

capacidade de [ENTENDIMENTO/AUTODETERMINAÇÃO], havendo nexo funcional entre o quadro mental e a conduta examinada.

Inconclusivo

Os dados disponíveis não permitem reconstruir com segurança o estado mental do examinado no momento do fato, especialmente pela ausência de [DOCUMENTOS/DADOS], razão pela qual a conclusão sobre imputabilidade deve permanecer limitada.

1.7 Quesitos frequentes

1. O acusado apresenta transtorno mental?
2. O transtorno estava presente ao tempo do fato?
3. O acusado entendia o caráter ilícito da conduta?
4. Podia se determinar conforme esse entendimento?
5. Há nexo entre transtorno mental e fato?
6. O uso de substâncias interferiu na capacidade penal?
7. Há risco de reiteração de violência?
8. Há indicação de tratamento psiquiátrico?
9. Há elementos de simulação?

1.8 Checklist final

- ☐ O momento do fato foi reconstruído?
- ☐ O diagnóstico está documentado?
- ☐ Há sintomas contemporâneos ao fato?
- ☐ Entendimento foi analisado separadamente?
- ☐ Autodeterminação foi analisada separadamente?
- ☐ O nexo sintoma-conduta foi explicitado?
- ☐ Substâncias foram consideradas?
- ☐ Simulação/dissimulação foi ponderada?
- ☐ A conclusão é proporcional aos dados?

Módulo 2 — Parecer Cível

2.1 Quando usar

Use em casos de:

- curatela;
- interdição;
- levantamento ou revisão de curatela;
- tomada de decisão apoiada;
- capacidade para testamento;
- capacidade para contrato;
- capacidade para venda/doação de bens;
- capacidade para procuração;
- consentimento para tratamento;
- vulnerabilidade a abuso financeiro;
- capacidade civil retrospectiva.

2.2 Pergunta médico-legal central

O examinado possui capacidade para compreender, apreciar, raciocinar e expressar escolha estável em relação ao ato civil específico?

2.3 Matriz de capacidade civil

Componente	Pergunta	Exemplo de prejuízo	Relevância
Compreensão	Entende a informação?	Não entende contrato ou valor do bem	Compromete consentimento
Apreciação	Entende que se aplica a si?	Não reconhece risco de golpe	Aumenta vulnerabilidade
Raciocínio	Compara alternativas?	Não avalia consequência patrimonial	Afeta atos complexos
Escolha	Expressa decisão estável?	Muda de decisão por sugestão externa	Sugere necessidade de apoio
Funcionalidade	Atua na vida real?	Não paga contas, perde dinheiro	Define extensão da medida

2.4 Estrutura recomendada

1. Objeto do parecer.
2. Ato civil em discussão.
3. Documentos analisados.
4. Histórico clínico e cognitivo.
5. Histórico funcional e patrimonial.
6. Exame do estado mental.
7. Avaliação cognitiva/funcional.
8. Quatro componentes decisórios.
9. Vulnerabilidade a abuso/manipulação.
10. Atos preservados.
11. Atos comprometidos.
12. Medida menos restritiva.
13. Conclusão.
14. Quesitos.

2.5 Conteúdo denso essencial

Capacidade não é global por padrão

A capacidade deve ser delimitada por ato. O examinado pode ser incapaz para alienar imóvel e capaz para decisões cotidianas simples.

Curatela proporcional

A curatela deve ser:

- necessária;
- proporcional;
- delimitada;
- menos restritiva possível;
- revisável.

Direitos existenciais

Mesmo quando há prejuízo patrimonial, preservar, sempre que possível:

- convivência familiar;
- vínculos afetivos;
- preferências pessoais;
- decisões cotidianas;
- participação social;
- dignidade.

Demência

Avaliar memória, julgamento, finanças, risco de golpe, crítica, funcionalidade e suporte.

Mania e capacidade civil

Atos patrimoniais em mania exigem análise retrospectiva: grandiosidade, desinibição, prejuízo crítico, temporalidade e consequência financeira.

2.6 Frases-modelo

Capacidade preservada

Apesar do diagnóstico de [DIAGNÓSTICO], o examinado demonstra compreensão, apreciação, raciocínio e expressão de escolha estável em relação ao ato avaliado, não havendo elementos suficientes para restrição de capacidade civil nos dados disponíveis.

Curatela parcial

Os achados indicam prejuízo relevante para atos patrimoniais e negociais complexos, especialmente [ATOS], preservando-se capacidade para decisões cotidianas e direitos existenciais. Recomenda-se medida proporcional limitada aos atos comprometidos.

Incapacidade ampla

O examinado apresenta comprometimento global e grave de cognição, julgamento e funcionalidade, sem capacidade atual para compreender, apreciar, raciocinar e expressar escolha estável em relação aos atos civis avaliados.

2.7 Quesitos frequentes

1. O periciando tem doença mental ou neurocognitiva?
2. A doença compromete atos da vida civil?
3. Quais atos estão comprometidos?
4. Quais atos estão preservados?
5. Há risco de abuso patrimonial?
6. Há necessidade de curatela?
7. A curatela deve ser total ou parcial?
8. Cabe tomada de decisão apoiada?
9. A incapacidade é temporária ou permanente?

2.8 Checklist final

- ☐ O ato civil específico foi definido?
 - ☐ Compreensão foi avaliada?
 - ☐ Apreciação foi avaliada?
 - ☐ Raciocínio foi avaliado?
 - ☐ Expressão de escolha foi avaliada?
 - ☐ Funcionalidade real foi descrita?
 - ☐ Vulnerabilidade foi analisada?
 - ☐ Atos preservados foram descritos?
 - ☐ A medida sugerida é proporcional?
-

Módulo 3 — Parecer Previdenciário e Administrativo

3.1 Quando usar

Use em casos de:

- licença médica;
- auxílio por incapacidade;
- aposentadoria por incapacidade;
- junta médica;
- servidor público;
- readaptação;
- reversão;
- capacidade residual;
- revisão de proventos;
- divergência entre médico assistente e perícia administrativa.

3.2 Pergunta central

O transtorno mental produz incapacidade funcional para o cargo ou atividade? A incapacidade é temporária ou permanente? Há possibilidade de readaptação? Há nexos funcional ou ocupacional?

3.3 Matriz funcional laboral

Domínio	Pergunta	Exemplo
Atenção	Sustenta foco na tarefa?	erros, dispersão, baixa produtividade
Memória	Retém instruções e rotinas?	esquecimento de procedimentos
Ritmo	Mantém produtividade?	lentificação, fadiga mental
Interação	Lida com público/equipe?	conflitos, isolamento, ansiedade
Pressão	Tolera cobrança?	descompensação sob demanda
Assiduidade	Mantém presença regular?	afastamentos recorrentes
Segurança	Há risco para si/terceiros?	impulsividade, ideação suicida

3.4 Estrutura recomendada

1. Cargo e descrição funcional.
2. Exigências psíquicas da atividade.
3. Histórico clínico longitudinal.
4. Tratamentos e resposta.
5. Histórico de afastamentos.
6. Tentativas de retorno/readaptação.
7. Diagnóstico atual.
8. Funcionalidade atual.
9. Capacidade para cargo habitual.
10. Capacidade residual.
11. Prognóstico.
12. Nexos/concausa, se aplicável.
13. Crítica de laudo administrativo.
14. Conclusão.

3.5 Conteúdo denso essencial

Diagnóstico não é incapacidade

A incapacidade depende da relação entre sintomas e exigências funcionais do cargo.

Longitudinalidade

Em psiquiatria, a evolução ao longo do tempo é frequentemente mais importante que um exame isolado.

Afastamento-retorno-recaída

Padrão de melhora com afastamento e piora com retorno pode ser indicador funcional relevante.

Readaptação

Avaliar se há função compatível com limitações, risco de recaída e preservação de capacidade residual.

3.6 Frases-modelo

A incapacidade psiquiátrica não decorre exclusivamente do diagnóstico, mas da repercussão funcional dos sintomas sobre as exigências concretas do cargo.

O padrão longitudinal de afastamentos, recaídas e resposta parcial ao tratamento sustenta prejuízo funcional persistente.

A ausência de análise de nexos no laudo administrativo não equivale, por si só, à exclusão técnica do nexos, quando tal questão não foi objeto da avaliação.

3.7 Checklist final

- ☐ Cargo foi descrito?
- ☐ Exigências funcionais foram analisadas?
- ☐ Evolução clínica foi reconstruída?
- ☐ Tratamentos foram descritos?
- ☐ Funcionalidade atual foi avaliada?
- ☐ Prognóstico foi discutido?

- ☐ Readaptação foi considerada?
 - ☐ Nexo/concausa foi analisado quando pertinente?
-

Módulo 4 — Parecer Trabalhista/Ocupacional

4.1 Quando usar

Use em casos de:

- assédio moral;
- burnout;
- TEPT ocupacional;
- depressão relacionada ao trabalho;
- ansiedade ocupacional;
- dano psíquico;
- nexo causal/concausal;
- incapacidade laboral;
- retorno ao trabalho;
- readaptação;
- exposição a violência, ameaça ou humilhação.

4.2 Pergunta central

Há relação causal ou concausal entre condições de trabalho e adoecimento psíquico? Há dano psíquico e incapacidade funcional decorrente?

4.3 Matriz de nexos ocupacional

Critério	O que procurar	Força probatória
Temporalidade	sintomas após exposição	essencial
Plausibilidade	mecanismo psicopatológico compatível	forte
Consistência	documentos convergentes	forte
Dose-resposta	piora com maior exposição	relevante
Reversibilidade	melhora com afastamento	relevante
Reexposição	recaída ao retorno	muito relevante
Alternativas	fatores extralaborais suficientes?	obrigatório

4.4 Conteúdo denso essencial

Assédio moral

Avaliar repetição, intencionalidade possível, humilhação, isolamento, desqualificação, documentação e impacto psíquico.

Burnout

Cuidado para não usar burnout como rótulo genérico. Avaliar exaustão, cinismo/distanciamento, queda de eficácia, contexto laboral e diferenciais com depressão.

TEPT ocupacional

Exige exposição traumática compatível, revivescência, esquiva, alterações negativas de cognição/humor, hiperreatividade e prejuízo funcional.

Depressão relacionada ao trabalho

Pode haver nexos causal, concausal ou agravamento, conforme temporalidade, contexto, vulnerabilidades e documentação.

4.5 Frases-modelo

A análise de nexos em psiquiatria ocupacional deve considerar temporalidade, plausibilidade clínica, evolução longitudinal, resposta ao afastamento e

presença de fatores alternativos suficientes.

A existência de vulnerabilidade individual não exclui concausalidade quando o trabalho atuou como fator relevante de precipitação, agravamento ou perpetuação do quadro.

4.6 Checklist final

- ☐ Estressores laborais foram descritos?
 - ☐ Sintomas começaram após ou durante exposição?
 - ☐ Há documentos contemporâneos?
 - ☐ Houve melhora com afastamento?
 - ☐ Houve piora com retorno?
 - ☐ Fatores extralaborais foram analisados?
 - ☐ Incapacidade foi vinculada à função?
 - ☐ Conclusão diferencia causa, concausa e agravamento?
-

Módulo 5 — Parecer de Dano Psíquico

5.1 Quando usar

Use em casos de:

- violência;
- acidente;
- erro médico;
- assédio;
- abuso;
- perda traumática;
- exposição ocupacional;
- dano moral com repercussão psíquica;
- responsabilidade civil.

5.2 Pergunta central

Houve transtorno ou sofrimento psíquico clinicamente significativo decorrente do evento? Qual a gravidade, duração, funcionalidade afetada e nexos?

5.3 Matriz de dano psíquico

Elemento	Avaliação
Evento	natureza, intensidade, duração
Sintomas	tipo, início, frequência, gravidade
Diagnóstico	TEPT, depressão, ansiedade, adaptação etc.
Funcionalidade	trabalho, relações, autocuidado, sono
Nexo	temporalidade e plausibilidade
Prognóstico	reversível, crônico, parcial
Tratamento	necessidade, adesão, resposta

5.4 Conteúdo denso essencial

Dano psíquico não é mero aborrecimento. Deve haver repercussão clínica, funcional e temporalmente relacionada ao evento.

5.5 Frase-modelo

Os elementos analisados são compatíveis com dano psíquico clinicamente relevante, caracterizado por [SINTOMAS/DIAGNÓSTICO], com repercussão funcional em [DOMÍNIOS] e nexos temporal/plausível com [EVENTO].

Módulo 6 — Análise Crítica de Laudo Judicial

6.1 Quando usar

Use quando atuar como assistente técnico para:

- concordar tecnicamente com laudo;
- complementar fundamentos;
- apontar lacunas;
- corrigir erro conceitual;
- responder impugnação;
- fortalecer tese médico-pericial da parte.

6.2 Matriz de crítica

Item	Pergunta
Metodologia	O laudo diz como avaliou?
Documentos	Considerou documentos essenciais?
EEM	Descreveu achados suficientes?
Diagnóstico	Está fundamentado?
Funcionalidade	Foi analisada?
Nexo	Foi discutido?
Quesitos	Foram respondidos?
Conclusão	Decorre dos achados?

6.3 Tipos de crítica

Lacuna metodológica

O laudo não explicita a metodologia utilizada para avaliar [PONTO].

Salto inferencial

A conclusão apresentada não decorre de forma suficientemente demonstrada dos achados descritos.

Omissão documental

Não houve discussão de documentos contemporâneos relevantes, especialmente [DOCUMENTOS].

Confusão conceitual

Observa-se confusão entre diagnóstico psiquiátrico e incapacidade funcional, conceitos relacionados, porém não equivalentes.

6.4 Checklist final

- ☐ Há pontos de concordância?
 - ☐ Há lacunas reais?
 - ☐ A crítica é técnica, não pessoal?
 - ☐ Cada crítica aponta consequência pericial?
 - ☐ A conclusão alternativa está fundamentada?
-

Módulo 7 — Simulação, Dissimulação e Consistência

7.1 Pergunta central

O relato e a apresentação clínica são consistentes com documentos, exame e curso esperado do transtorno?

7.2 Indicadores de alerta

- sintomas caricaturais;
- relato excessivamente teatral;
- inconsistência entre queixa e funcionalidade;
- melhora/piora incompatível;
- sintomas raros alegados de forma estereotipada;
- ganho externo evidente;
- ausência de história longitudinal;
- contradições documentais importantes.

7.3 Cuidado

Inconsistência não é sinônimo de simulação. Pode haver psicose, demência, trauma, ansiedade, vergonha, baixa escolaridade ou má compreensão.

7.4 Frase-modelo

Foram observadas inconsistências que reduzem a confiabilidade de determinados dados e recomendam cautela interpretativa. Tais inconsistências, isoladamente, não permitem concluir categoricamente por simulação.

Módulo 8 — Quesitos, Conclusão e Linguagem Pericial

8.1 Como responder quesitos

Boa resposta tem:

1. resposta direta;
2. fundamento técnico;
3. limite de certeza;
4. indicação de insuficiência quando houver;
5. recusa elegante de premissa falsa.

8.2 Modelo

Resposta: [SIM/NÃO/PARCIALMENTE/NÃO HÁ ELEMENTOS].
Fundamentação: [ACHADOS]. **Limitação:** [SE HOUVER].

8.3 Conclusão forte

Uma conclusão forte é:

- curta;
- proporcional;
- rastreável;
- sem excesso jurídico;
- vinculada ao objeto;
- capaz de responder ao juízo.

8.4 Frases úteis

Não há elementos suficientes nos dados fornecidos para concluir sobre este ponto.

A conclusão deve ser interpretada nos limites da documentação disponível.

O diagnóstico, isoladamente, não determina a conclusão médico-legal.

A repercussão funcional documentada é o elemento central para a análise de incapacidade.

A inferência de nexos exige análise de temporalidade, plausibilidade e fatores alternativos.

Encerramento

O parecer psiquiátrico-forense robusto deve ser construído como uma cadeia lógica:

1. pergunta médico-legal;
2. dados confiáveis;
3. psicopatologia;
4. funcionalidade;
5. nexos com ato/demanda;
6. conclusão proporcional;
7. resposta objetiva a quesitos.

Se qualquer elo estiver fraco, a conclusão deve ser limitada ou reformulada.